PRESCRIÇÃO

NO PRONTO SOCORRO



FICHA VERDE

ADULTO

_PRESCREVENDO

BÔNUS
AVC
IAM
CAD

Orientações para uso do material

SUMÁRIO INTERATIVO:

- *O sumário é **interativo**: basta clicar no nome do tema desejado para ser direcionado imediatamente a ele.*
- *Além disso, todas as páginas possuem o botão "**Voltar ao Sumário**", facilitando a navegação pelo ebook.*

PRESCRIÇÕES:

De acordo com o tema abordado, a prescrição pode ser apresentada de formas diferentes conforme a explicação abaixo:

Prescrição no Pronto Socorro

*É a prescrição utilizada para os medicamentos que serão administrados durante o atendimento inicial **no pronto socorro**.*

Prescrição Ambulatorial

*É a prescrição entregue ao paciente em receituário para que ele continue o tratamento em casa após receber **alta do pronto socorro.***

Prescrição Hospitalar

*É a prescrição utilizada para pacientes que necessitam de **internação hospitalar**.*

Prescrição Hospital Dia

*É a prescrição utilizada em regimes de tratamento em que o paciente **retorna ao hospital diariamente** para administração de medicamentos, mas não permanece internado.*

SUMÁRIO

Analgesia.....7

Prescrição no Pronto Socorro.....13
Prescrição Ambulatorial.....14

Cardiologia.....15

Edema Agudo de Pulmão Hipertensivo Perfil B.....16
Prescrição no Pronto Socorro.....17

Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST.....18
Prescrição no Pronto Socorro-Angioplastia Primária..18
Prescrição no Pronto Socorro - Trombólise.....20

Dermatologia.....25

Infarto Agudo do Miocárdio sem Supra de ST.....23
Prescrição no Pronto Socorro.....23

Alergia Leve/Moderada.....26
Prescrição no Pronto Socorro.....27
Prescrição Ambulatorial.....27

Anafilaxia.....28

Prescrição no Pronto Socorro.....28

Celulite/Erisipela.....28

Prescrição Hospitalar.....29
Prescrição Hospital Dia.....29
Prescrição Ambulatorial.....29

Endocrinologia.....30

CAD/EHH.....31
Prescrição no Pronto Socorro.....34

Hiperglicemia Assintomática.....34

Hipoglicemia.....35
Prescrição no Pronto Socorro.....36

SUMÁRIO

Gastroenterologia.....37

Cólica Abdominal.....38
Prescrição no Pronto Socorro.....39
Prescrição Ambulatorial.....39

Constipação.....40
Prescrição no Pronto Socorro.....40
Prescrição Ambulatorial.....40

Diarreia Aguda.....42
Prescrição Ambulatorial.....43

Dispepsia.....44
Prescrição no Pronto Socorro.....44
Prescrição Ambulatorial.....44

Náusea/Vômito.....45
Prescrição no Pronto Socorro.....45
Prescrição Ambulatorial.....46

Pirose.....46
Prescrição no Pronto Socorro.....46

Infectologia.....47

Profilaxia Pós Exposição (PEP).....48
Prescrição no Pronto Socorro e no Ambulatório.....48

Tuberculose.....48
Prescrição no Pronto Socorro e no Ambulatório.....49

Neurologia.....50

AVC Isquêmico - Indicação de Trombólise.....51
Prescrição no Pronto Socorro.....51
Prescrição do Trombolítico (Alteplase - rtPA).....53

AVC Isquêmico - sem indicação de Trombólise.....53
Prescrição no Pronto Socorro.....53

Cefaleia Primária - Migrânea (Enxaqueca).....54
Prescrição no Pronto Socorro.....54
Prescrição Ambulatorial.....55

SUMÁRIO

Cefaleia Primária - Tensional.....56
Prescrição no Pronto Socorro.....56
Prescrição Ambulatorial.....56
Crise Convulsiva.....57
Prescrição no Pronto Socorro.....57
Status de Mal Epiléptico.....57
Prescrição no Pronto Socorro.....57
Oftalmologia.....58
Hordéolo.....59
Prescrição Ambulatorial.....59
Conjuntivite Viral.....60
Prescrição Ambulatorial.....60
Conjuntivite Bacteriana.....60
Prescrição Ambulatorial.....61
Ortopedia.....62
Dor Lombar Mecânica.....63
Prescrição no Pronto Socorro.....65
Prescrição Ambulatorial.....65
Otorrinolaringologia.....66
Cerume Impactado.....67
Prescrição Ambulatorial.....67
Faringoamigdalite Estreptocócica.....68
Prescrição no Pronto Socorro.....68
Prescrição Ambulatorial.....68
Otite Externa.....68
Prescrição Ambulatorial.....69
Paralisia de Bell.....69
Prescrição Ambulatorial.....70
Rinite Alérgica Intermitente.....70
Prescrição Ambulatorial.....70

SUMÁRIO

Rinite Alérgica Persistente....71
Prescrição Ambulatorial....71
Rinossinusite Bacteriana....71
Prescrição Ambulatorial....72

Pneumologia....73

Crise Asmática....74
Prescrição no Pronto Socorro....74
Prescrição Ambulatorial (Após Alta do PS)....74

Pneumonia....75
Prescrição Ambulatorial....76
Prescrição Hospitalar....76

Psiquiatria....77

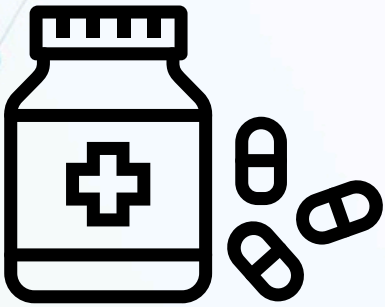
Agitação Psicomotora....78
Prescrição no Pronto Socorro....78
Síndrome de Abstinência Alcoólica....78
Prescrição no Pronto Socorro....79
Crise de Ansiedade e Crise de Pânico....79
Prescrição no Pronto Socorro....79

Urologia....80

Cólica Nefrética....81
Prescrição no Pronto Socorro....81
Cistite (ITU Baixa)....82
Prescrição Ambulatorial....82
Pielonefrite (ITU Alta)....83
Prescrição Ambulatorial....83
Prescrição Hospitalar....83

Infecções Virais....84

Dengue....85
Prescrição Ambulatorial....88
Prescrição no Pronto Socorro....89
Resfriado....90
Prescrição Ambulatorial....93



ANALGESIA

ANALGESIA

ESCALA DA DOR

PARA ANALGESIA ADEQUADA AVALIE A INTENSIDADE DA DOR E

PRESCREVA O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO:

ESCALA DA DOR:

SEM DOR - **0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -** DOR INSUPORTÁVEL

DOR LEVE **DOR MODERADA** **DOR FORTE**

DOR LEVE:
- Analgésico e/ou AINE

DOR MODERADA:
- Analgésico e/ou AINE + Opioide Fraco

DOR FORTE:
- Analgésico e/ou AINE + Opioide Forte

Alguns exemplos de medicamentos de acordo com sua classe:

ANALGÉSICO	AINE	OPIOIDE FRACO	OPIOIDE FORTE
Dipirona	Diclofenaco	Tramadol	Morfina
Paracetamol	Ibuprofeno	Codeína	

ANALGESIA

ANALGÉSICOS SIMPLES

VIA ORAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	DOSE	FREQUÊNCIA
Dipirona	500 mg/cp	1-2 cp	6/6 h
Dipirona	1 g/cp	1 cp	6/6 h
Dipirona	500 mg/mL	20-40 gts	6/6 h
Paracetamol	500 mg/cp	1-2 cp	6/6 h
Paracetamol	750 mg/cp	1 cp	6/6 h
Paracetamol	200 mg/mL	35-55 gts	6/6 h

VIA PARENTERAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	FREQUÊNCIA
Dipirona	1 g/2mL	2 mL + 18 mL AD EV	6/6h
Dipirona	1 g/2mL	2 mL IM	6/6h
Paracetamol	10 mg/mL	50-100 mL EV	6/6h

AINE (ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES)

VIA ORAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	DOSE	FREQUÊNCIA
Cetoprofeno	100 mg/cp	1 cp	12/12 h
Diclofenaco	50 mg/cp	1 cp	8/8 h
Nimesulida	100 mg/cp	1 cp	12/12 h
Ibuprofeno	200-600 mg/cp	1 cp	8/8 h
Tenoxicam	20 mg/cp	1 cp	24/24 h
Cetorolaco	10 mg/cp	1 cp (via SL)	8/8 h

ANALGESIA

AINE (ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES)

VIA PARENTERAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	FREQUÊNCIA
Cetoprofeno	100 mg/fr	1 fr + SF0,9% 100 mL EV	2-3x/dia
Cetoprofeno	100 mg/2mL	2 mL IM	2-3x/dia
Tenoxicam	20 mg/fr	1 fr + 2 mL AD EV	1x/dia
Tenoxicam	20 mg/fr	1 fr + 2 mL AD IM	1x/dia
Diclofenaco	75 mg/3mL	3 mL IM	1x/dia
Cetorolaco	30 mg/mL	0,5-1 mL EV	8/8 h
Cetorolaco	30 mg/mL	0,5-1 mL IM	8/8 h

AINE SELETICO COX-2

VIA ORAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	DOSE	FREQUÊNCIA
Celecoxibe	100 mg/cp	1-2 cp	12/12 h
Etoricoxibe	90 mg/cp	1 cp	24/24 h

CORTICOIDE (DOSE ANTI-INFLAMATÓRIA)*

***ORIENTO PRESCREVER SOMENTE NO PRONTO SOCORRO**

VIA ORAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	DOSE	FREQUÊNCIA
Prednisona	5-20 mg/cp	20-40 mg	Dose única

ANALGESIA

CORTICOIDE (DOSE ANTI-INFLAMATÓRIA)*

***ORIENTO PRESCREVER SOMENTE NO PRONTO SOCORRO**

VIA PARENTERAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	FREQUÊNCIA
Dexametasona	10 mg/2,5mL	1 a 2,5 mL + 9 a 17,5 mL AD EV	Dose única

OPIOIDE FRACO

VIA ORAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	DOSE	FREQUÊNCIA
Codeína	30 mg/cp	1 cp	6/6 h
Tramadol	50 mg/cp	1 cp	6/6 h

VIA PARENTERAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	FREQUÊNCIA
Tramadol	50/mL	1-2 mL + SF0,9% 100 mL EV	6/6 h

OPIOIDE FORTE

VIA ORAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	DOSE	FREQUÊNCIA
Morfina	10 mg/cp	1 cp	4/4 h
Metadona	5 mg/cp	1 cp	4/4 h

ANALGESIA

OPIOIDE FORTE

VIA PARENTERAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	FREQUÊNCIA
Morfina	10 mg/mL	1 mL + SF0,9% 9 mL, administrar 3 mL EV	6/6 h

RELAXANTE MUSCULAR

VIA ORAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	DOSE	FREQUÊNCIA
Ciclobenzaprina	5-10 mg/cp	1-2 cp	8/8 h

VIA PARENTERAL

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	FREQUÊNCIA
Tiocolchicosídeo	4 mg/mL	2 mL IM	12/12 h

ANALGESIA



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

DOR AGUDA LEVE

1) Dipirona 1000 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD via EV

OU

1) Dipirona 1000 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD via EV

2) Dexametasona 4 mg/mL – 2,5 mL + 17,5 mL AD via EV

DOR AGUDA MODERADA

1) Dipirona 1000 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD via EV

2) Dexametasona 10mg/2,5mL – 2,5 mL + 17,5 mL AD via EV

3) Diclofenaco 75 mg/3mL – 3 mL via IM

DOR AGUDA INTENSA

1) Dipirona 1000 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD via EV

2) Tramadol 50 mg/mL – 1 a 2 mL + SF0,9% 100 mL via EV

OU

1) Dipirona 1000 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD via EV

2) Morfina 10 mg/mL – 1 mL + SF0,9% 9 mL, administrar 3 mL via EV



ANALGESIA

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

DOR AGUDA LEVE/MODERADA

1) Dipirona 500 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 a 2 comprimido(s), via oral, de 6/6h, se dor.

Se necessário, associar com AINE:
2) Diclofenaco 50 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, por até 5 dias seguidos, se dor intensa.

DOR AGUDA MODERADA/INTENSA

1) Dipirona 500 mg ---------- 1 cx
Tomar 1 a 2 comprimido(s), via oral, de 6/6h, se dor.

2) Diclofenaco 50 mg ---------- 1 cx
Tomar 1 comprimido via oral de 8/8h, por até 5 dias seguidos, se dor intensa.

3) *Tramadol 50 mg ---------- 1 cx
Tomar 1 comprimido, via oral, de 6/6h, se dor intensa refratária a analgesia inicial

*Tramadol 50 mg é prescrito em receita de controle especial em duas vias



CARDIOLOGIA

EDEMA AGUDO DE PULMÃO HIPERTENSIVO PERFIL B

ESQUEMA DE TRATAMENTO

1) Vasodilatador endovenoso

- **Nitroprussiato 50 mg/2mL EV em BIC**
  - Titular BIC de 2 em 2mL/h a cada 3-5 min (MÁX: 45 mL/h)
  #PAS Alvo: 110-130 mmHg**#**

2) Diurético de alça

- **Furosemida 20 mg/2mL EV**
  - Dose inicial: 0,5 – 1 mg/kg
    Ex: 70 KG = 3,5 - 7,0 mL)

  - Dose para usuário crônico: 1-2x dose usual
    1cp VO (40 mg) = 1 amp EV (20 mg)
    Ex: 2 cp/dia = 2 a 4 amp EV

  # Reavaliar após 20 min e repetir, se necessário **#**

3) VNI

- **CPAP, se satO2 < 90 %**
  Pressão: 5-10 cmH2O
  Volume corrente: 6-8 mL/h

  # SatO2 alvo: 90-94% **#**

EDEMA AGUDO DE PULMÃO HIPERTENSIVO PERFIL B



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

PACIENTE SEM USO CRÔNICO DE FUROSEMIDA

1) Nitroprussiato 50 mg/2mL – Diluir 2 mL em SG5% 248 mL e infundir via EV em BIC a 2 mL/h
2) Furosemida 20 mg/2mL – administrar 4 mL via EV em bolus
3) Oxigênio suplementar com VNI CPAP – 5 cmH2O, se SATO2<90%

PACIENTE EM USO CRÔNICO DE FUROSEMIDA (2 CP/DIA: 80 MG/DIA)

1) Nitroprussiato 50 mg/2mL – Diluir 2 mL em SG5% 248 mL e infundir via EV em BIC a 2 mL/h
2) Furosemida 20 mg/2mL – administrar 8 mL via EV em bolus
3) Oxigênio suplementar com VNI CPAP – 5 cmH2O, se SATO2<90%

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DE ST

ATT: Seguir sempre o protocolo adotado pela instituição. As sugestões de prescrição a seguir devem ser utilizadas como norteadoras.



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

PACIENTE CANDIDATO À ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA

1) Dieta oral zero **2)** AAS 100 mg/cp – administrar 3 cp (300 mg), via oral (mastigar e engolir), imediatamente
3) Clopidogrel 75 mg/cp – administrar 8 cp (600 mg), via oral, imediatamente
4) *Dinitrato de Isossorbida 5 mg/cp – administrar 1 cp, via sublingual, a cada 5 min, se dor torácica (Máx.: 3 cp - 15 mg)
5) *Nitroglicerina 25mg/5mL – diluir 10 mL em SG5% 240 mL e administrar via EV em BIC 3 mL/h, se dor torácica refratária ao Nitrato SL e/ou PA elevada - incrementar 3 mL/h a cada 5 min até melhora sintomática ou redução da PA (Máx: 45 mL/h – 120mL/h) PA alvo: 130x90 mmHg
6) *Morfina 10 mg/mL – diluir 1 mL em 9 mL de SF0,9%, administrar 2 mL a cada 5 min, se dor torácica refratária ao Nitrato SL e EV (Máx.: 25 mg)
7) Rosuvastatina 40 mg/cp – administrar 1 cp VO 1 vez por dia
8) *Enalapril 10 mg/cp – administrar 1 cp VO 12/12h
9) Monitorização contínua
10) *Glicemia capilar de 6/6h – manter glicemia entre 70-180 mmHg
11) CN O2 2-3 l/min, se SATO2 < 90% ou SpO2 < 60 mmHg

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DE ST

PACIENTE CANDIDATO À ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA

***Nitrato**

- Contraindicações:
  - Uso de Tadalafil/Sildenafil nas últimas 24h;
  - IAMCST com Infarto de VD associado;
  - Hipotensão (PAS < 110 mmHg)

***Morfina:**

- O nitrato (via SL e/ou EV) deve ser utilizado como analgesia de primeira escolha para alívio da dor torácica. Somente se dor refratária ao nitrato, orienta-se a administração de morfina. Não utilizar morfina rotineiramente; Contraindicada se IAMCSST com Infarto de VD associado;

***IECA:**

- Administrar em todos os pacientes com DM e/ou HAS e/ou ICFER
- Se intolerância, trocar por BRA

***Glicemia capilar:**

- Se necessário, o controle da hiperglicemia pode ser feito com a administração de Insulina Regular via SC de acordo com a escala exemplificada abaixo:
  - 181-200: 2 UI // 201-250: 4 UI // 251-300: 6UI // 301-350: 8UI // 351-400: 10 UI // ≥ 400: 12 UI

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DE ST

PACIENTE CANDIDATO À TROMBÓLISE

1) Dieta oral zero
2) AAS 100 mg/cp – administrar 3 cp (300 mg), via oral (mastigar e engolir), imediatamente **3)** *Clopidogrel 75 mg/cp – administrar 4 cp (300 mg), via oral, imediatamente
4) *Enoxaparina 60 mg/0,6mL – administrar 0,3 mL (30 mg), via ENDOVENOSA, imediatamente
5) *Enoxaparina – administrar 1mg/kg, via SC, de 12/12h – iniciar 15 minutos após administração do item 4
6) *TROMBOLÍTICO via EV (ver a seguir)
7) *Dinitrato de Isossorbida 5 mg/cp – administrar 1 cp, via sublingual, a cada 5 min, se dor torácica (Máx.: 3 cp - 15 mg)
8) *Nitroglicerina 25mg/5mL – diluir 10 mL em SG5% 240 mL e administrar via EV em BIC 3 mL/h, se dor torácica refratária ao Nitrato SL e/ou PA elevada - incrementar 3 mL/h a cada 5 min até melhora sintomática ou redução da PA (Máx: 45 mL/h – 120mL/h) PA alvo: 130x90 mmHg
9) *Morfina 10 mg/mL – diluir 1 mL em 9 mL de SF0,9%, administrar 2 mL a cada 5 min, se dor torácica refratária ao Nitrato SL e EV (Máx.: 25 mg)
10) Rosuvastatina 40 mg/cp – administrar 1 cp VO 1 vez por dia
11) *Enalapril 10 mg/cp – administrar 1 cp VO 12/12h
12) Monitorização contínua
13) *Glicemia capilar de 6/6h – manter glicemia entre 70-180 mmHg
14) CN O2 2-3 l/min, se SATO2 < 90% ou SpO2 < 60 mmHg

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DE ST

PACIENTE CANDIDATO À TROMBÓLISE

***Clopidogrel:**

- Se idade ≥ 75 anos, administrar 1 cp (75 mg)

***Enoxaparina:**

- As duas primeiras doses (dose EV + primeira dose SC) não devem ultrapassar 100 mg no total. Ex:
  - Pct 70 kg (30 mg EV + 70 mg SC 12/12h);
  - Pct 80 kg (30 mg EV + 70 mg SC após 15 min da dose EV – após 12h, fazer ajuste para 80 mg SC 12/12h)
- Se idade ≥ 75 anos: não fazer bolus EV. Administrar dose de 0,75 mg/kg SC de 12/12h
- Se TFG≤30: não fazer boléusEV. Administrar dose de 1 mg/kg SC 1x/dia

***Nitrato:**

- Contraindicações:
  - Uso de Tadalafil/Sildenafil nas últimas 24h;
  - IAMCSST com Infarto de VD associado;
  - Hipotensão (PAS < 110 mmHg)

***Morfina:**

- O nitrato (via SL e/ou EV) deve ser utilizado como analgesia de primeira escolha para alívio da dor torácica. Somente se dor refratária ao nitrato, orienta-se a administração de morfina.
- Não utilizar morfina rotineiramente;
- Contraindicada se IAMCSST com Infarto de VD associado;

***IECA:**

- Administrar em todos os pacientes com DM e/ou HAS e/ou ICFER
- Se intolerância, trocar por BRA

***Glicemia capilar:**

- Se necessário, o controle da hiperglicemia pode ser feito com a administração de Insulina Regular via SC de acordo com a escala exemplificada abaixo:
  - 181-200: 2 UI // 201-250: 4 UI // 251-300: 6UI // 301-350: 8UI // 351-400: 10 UI // ≥ 400: 12 UI



INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DE ST

PACIENTE CANDIDATO À TROMBÓLISE

***Trombolítico:**
Avaliar atentamente as contraindicações absolutas e relativas antes de administrar o medicamento

- **TENECTEPLASE 5 mg/ml:**
  - Administrar via EV em bolus, por 5-10 segundos, de acordo com o peso do paciente:

<60kg: 30 mg **(6 mL)**
60-69 kg: 35 mg **(7 mL)**
70-79 kg: 40 mg **(8 mL)**
80-89 kg: 45 mg **(9 mL)**
≥90 kg: 50 mg **(10 mL)**

Se idade maior que 75 anos,
considerar 50% da dose recomendada

- **ALTEPLASE 1 mg/ml**:
  - Paciente > 65 kg
    - Administrar 15 mL (15 mg) via EV em bolus, por 1-2 minutos, seguido de 50 mL (50 mg) via EV em 30 minutos e, após, 35 mL (35 mg) via EV em mais 60 minutos.
  - Paciente < 65 kg
    - Administrar 15 mL (15 mg) via EV em bolus (1-2 minutos), seguido de 0,75mg/kg (máx.: 50 mg) via EV em 30 minutos e, após, 0,5 mg/kg (máx.: 35 mg) via EV em 60 minutos.
  - ATT.: A dose total não deve exceder 100 mg

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM SUPRA DE ST

ATT: Seguir sempre o protocolo adotado pela instituição. As sugestões de prescrição a seguir devem ser utilizadas como norteadoras.



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Dieta oral branda (Dieta zero, se CATE em menos de 12h) **2)** AAS 100 mg/cp – administrar 3 cp (300 mg) via oral (mastigar e engolir), imediatamente
3) *Clopidogrel 75 mg/cp – administrar 4 cp (300 mg) via oral, imediatamente
4) *Enoxaparina - administrar 1 mg/kg, via SC, de 12/12H
5) *Dinitrato de Isossorbida 5 mg/cp – Administrar 1 cp, via sublingual, a cada 5 min, se dor torácica (Máx.: 3 cp - 15 mg)
6) *Nitroglicerina 25mg/5mL – diluir 10 mL em SG5% 240 mL e administrar via EV em BIC 3 mL/h, se dor torácica refratária ao Nitrato SL e/ou PA elevada - incrementar 3 mL/h a cada 5 min até melhora sintomática ou redução da PA (Máx: 45 mL/h – 120mL/h) PA alvo: 130x90 mmHg
7) *Atenolol 25 mg/cp – administrar 1 cp, VO, de 12/12h
8) *Enalapril 10 mg/cp – administrar 1 cp, VO, de 12/12h
9) Rosuvastatina 40 mg/cp – administrar 1 cp, VO, uma vez por dia
10) Monitorização contínua
11) *Glicemia capilar de 6/6h – manter glicemia entre 70-180 mmHg
12) CN O2 2-3 l/min, se SATO2 < 90% ou SpO2 < 60 mmHg

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM SUPRA DE ST

***Clopidogrel:**

- Não administrar se realização de CATE for em menos de 24h

***Enoxaparina:**

- Se idade ≥ 75 anos: não fazer bolus EV. Administrar dose de 0,75 mg/kg SC de 12/12h
- Se TFG≤30: não fazer bolus EV. Administrar dose de 1 mg/kg SC 1x/dia

***Nitrato:**

- Contraindicações:
  - Uso de Tadalafil/Sildenafil nas últimas 24h;
  - IAMCST com Infarto de VD associado;
  - Hipotensão (PAS < 110 mmHg)

***Betabloqueador:**

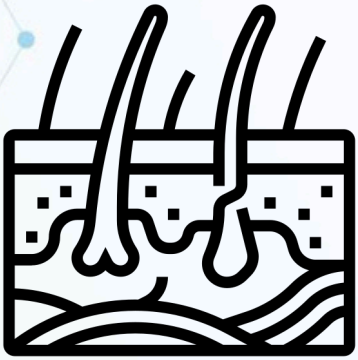
- Não administrar betabloqueador se bradicardia, hipotensão ou risco para choque cardiogênico

***IECA:**

- Administrar em todos os pacientes com DM ou HAS ou ICFER
- Se intolerância, trocar por BRA

***Glicemia capilar:**

- Se necessário, o controle da hiperglicemia pode ser feito com a administração de Insulina Regular via SC de acordo com a escala exemplificada abaixo:
  - 181-200: 2 UI // 201-250: 4 UI // 251-300: 6UI // 301-350: 8UI // 351-400: 10 UI // ≥ 400: 12 UI



DERMATOLOGIA

ALERGIA LEVE/MODERADA

OPÇÕES DE TRATAMENTO

PROCESSO ALÉRGICO LEVE

Escolha uma das opções
(não sedantes é a primeira escolha)

Não sedantes:

- Loratadina 10 mg/cp - 01 comprimido, via oral, 1 vez por dia
- Desloratadina 5 mg/cp - 01 comprimido, via oral, 1 vez por dia
- Fexofenadina 120 mg/cp - 01 comprimido, via oral, 1 vez por dia
- Bilastina 20 mg/cp - 01 comprimido, via oral, 1 vez por dia

Sedantes:

- Via oral
  - Prometazina 25 mg/cp - 01 comprimido, via oral, de 8/8h
  - Dexclorfeniramina 2 mg/cp - 01 comprimido, via oral, de 8/8h
  - Hidroxizina 25 mg/cp - 01 comprimido, via oral, de 8/8h

- Via parenteral
  - Prometazina 50mg/2mL - 2 mL via IM (MÁX: 100mg/dia)



ALERGIA LEVE/MODERADA



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

PROCESSO ALÉRGICO MODERADO

1) Prometazina injetável 50 mg/2ml – administrar 2 mL, via IM profundo
2) Hidrocortisona injetável 100 mg/fr – diluir 2 fr em 50 mL de SF0,9% e administrar via EV em 15 minutos
OU
2) Metilprednisolona injetável 125 mg/fr – reconstituir 1 fr em 2 mL do diluente próprio e diluir em SF0,9% 50 mL – administrar via EV em 30 minutos

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

PROCESSO ALÉRGICO LEVE

1) Loratadina 10 mg ---------- 1 cx
Tomar 1 comprimido, via oral, uma vez por dia, se alergia.

PROCESSO ALÉRGICO MODERADO

1) Loratadina 10 mg---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, uma vez por dia, por 5 dias.

2) Prednisona 20 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, uma vez por dia, pela manhã, por 5 dias.



ANAFILAXIA

TRATAMENTO

- Adrenalina 1 mg/mL – administrar 0,5 mL via IM (pode repetir a cada 5-15 min por até 3 vezes)



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Dieta oral zero
2) Adrenalina 1 mg/mL – aplicar 0,5 mL via IM em face anterolateral da coxa
3) SF 0,9% 1000 mL – correr via EV em 1 hora

CELULITE/ERISIPELA

OPÇÕES DE TRATAMENTO (MONOTERAPIA)

- Via oral:
  - Amoxicilina + Clavulanato 875+125mg/cp – 1 cp, VO, 12/12h, por 7 dias
  - Cefadroxila 500 mg/cp – 1 cp, VO, 12/12h, por 7 dias
  - Cefalexina 500 mg/cp – 1 cp, VO, 6/6h, por 7 dias

- Via parenteral:
  - Oxacilina 500 mg/fr – 2 g, via EV, 4/4h, por 7 dias
  - Ceftriaxona 1 g/fr – 1 g, via EV, 12/12h, por 7 dias
  - Ceftriaxona 1g/fr – 2 g, via EV, 24/24h, por 7 dias
  - Clindamicina 600 mg/4mL – 600 mg, via EV, 8/8h, por 7 dias



CELULITE/ERISIPELA

PRESCRIÇÃO HOSPITALAR

1) Oxacilina 500 mg/fr – reconstituir 4 fr em 5 mL AD cada frasco e diluir em SF0,9% 100 mL – administrar via endovenosa, em 30 minutos, de 4/4h, por 7 dias

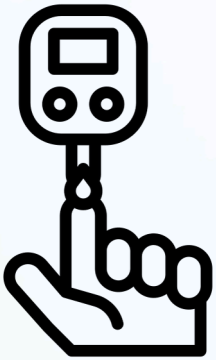
PRESCRIÇÃO HOSPITAL DIA

1) Ceftriaxona 1 g/fr – reconstituir 2 fr em 10 mL AD cada e diluir em SF0,9% 100 mL – administrar via endovenosa, em 30 minutos, 1 vez por dia, por 7 dias

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Cefalexina 500 mg ---------- 28 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, de 6/6h, por 7 dias



ENDOCRINOLOGIA

CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD) / ESTADO HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR (EHH)

ESQUEMA DE TRATAMENTO

HIDRATAÇÃO VENOSA (hv)

Fase 1: Primeira hora (assim que o paciente chegar)

- SF 0,9% 1000 a 1500 mL (15-20 mL/kg)
  - Se for necessário seguir com ressuscitação volêmica para estabilidade hemodinâmica, considerar Ringer Lactato e aminas vasoativas.

Fase 2: Após a primeira hora

- Manter HV 250-500 mL/h (4 mL/kg/h) até exames

CHECAR POTÁSSIO SÉRICO (k)

- Após exames, manter HV 250-1000 mL/h de acordo com Na corrigido* e K séricos. Se:
  - **K < 3,3 e Na < 135:**
    - SF 0,9% 1000 mL + KCl 19,1% 10 mL (ou KCl 10% 20 mL) EV em 1 hora
  - **K < 3,3 e Na ≥ 135:**
    - NaCl 0,45%** 1000 mL + KCl 19,1% 10 mL (ou KCl 10% 20 mL) EV em 1 hora
  - **K entre 3,3 a 5,0 e Na < 135:**
    - Insulinoterapia + SF 0,9% 1000 mL + KCl 19,1% 10 mL (ou KCl 10% 20 mL) EV em 2 horas

- **K entre 3,3 a 5,0 e Na ≥ 135:**
  - Insulinoterapia + NaCl 0,45%** 1000 mL + KCl 19,1% 10 mL (ou KCl 10% 20 mL) EV em 2 horas

- **K > 5,0 e Na < 135:**
  - Insulinoterapia + SF 0,9% 1000 mL EV em 2 horas

- **K > 5,0 e Na ≥ 135:**
  - Insulinoterapia + NaCl 0,45%** 1000 mL EV em 2 horas

INSULINOTERAPIA

Fase 3: Insulinoterapia

- Insulina Regular 100 UI (1 ml) + SF 0,9% 99 mL – administrar via EV a 0,1 Ui/kg/h em BIC (Pct 70 kg = 7 mL/h)
  Glicemia capilar 1/1h
- Ajustar velocidade de infusão de acordo com glicemia capilar (HGT)
-
  - ALVO: reduzir HGT 50-75 mg/dL/h
    - Se redução de HGT > 75 mg/dL/h = Reduzir velocidade da BIC à metade
    - Se redução de HGT < 50 mg/dL/h = Dobrar velocidade da BIC

*Na corrigido = Sódio medido + 0,016 * (Glicose sérica - 100)

**NaCl 0,45% 500 mL (SF 0,9% 250 mL + água destilada 250 mL)

CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD) / ESTADO HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR (EHH)

ATT: EVITAR HIPOGLICEMIA

- **SE HGT < 200-250 MG/DL NA FASE 2:**

  MANTER SF 0,9% OU NACL 0,45% +/- KCL
  +
  INICIAR SG 5% 250 ML/H
  +
  GLICEMIA CAPILAR 1/1H

- **SE HGT < 200-250 MG/DL NA FASE 3:**

  MANTER SF 0,9% OU NACL 0,45% +/- KCL
  +
  MANTER INSULINA REGULAR EM BIC
  E REDUZIR VAZÃO À METADE
  +
  INICIAR SG 5% 250 ML/H
  +
  GLICEMIA CAPILAR 1/1H

GLICEMIA ALVO = 150-200 MG/DL ATÉ REVERSÃO DA CAD/EHH

CETOACIDOSE DIABÉTICA/ ESTADO HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

- Prescrição enquanto aguarda resultados dos exames laboratoriais.
- Identificar e tratar o fator desencadeante.
- Solicitar: Gasometria arterial; Hemograma; PCR; Dosagem de eletrólitos (Na, K, Cl); Função renal (Ur, Cr); EAS; Rx de Tórax.

1) Dieta oral zero
2) SF 0,9% 1500 mL, via EV, em 1 hora
3) SF 0,9% 500 mL/h, via EV - iniciar após administração do item 2
4) Monitorização contínua
5) Glicemia capilar 1/1h

- Após recebimento dos exames laboratoriais, realizar ajustes na prescrição de acordo com o "esquema de tratamento˜.

HIPERGLICEMIA ASSINTOMÁTICA (DESCOMPENSAÇÃO CRÔNICA)

- Considerar ajuste do tratamento ambulatorial e orientar sobre a importância da adesão ao tratamento
- Encaminhar para a APS (Atenção Primária à Saúde)
- Orientar sobre sinais de alarme para emergências hiperglicêmicas (CAD/EHH)
- A administração de insulina no pronto socorro não é recomendada para casos de descompensação crônica



HIPOGLICEMIA

TRATAMENTO

HIPOGLICEMIA LEVE (DX < 70 MG/DL)

Tratamento via oral (Se condições de deglutir):

- **Oferecer 15 g de carboidrato**
  Escolha uma das opções abaixo:
  - 1 colher de sopa rasa de açúcar ou de mel
  - 150 mL de refrigerante comum
  - 150 mL de suco de laranja
  - 3 balas de caramelo

HIPOGLICEMIA GRAVE (DX < 54 MG/DL) OU SEM CONDIÇÕES DE DEGLUTIR

T**ratamento endovenoso:**

- Glicose 50% - 40 mL EV
  +
  SG 5% 100 mL/h EV, até estabilidade clínica

Tratamento intramuscular:

- Glucagon 1 mg/fr - 1 ml via IM

APÓS REVERSÃO (DX > 70 MG/DL), OFERECER UM LANCHE.

HIPOGLICEMIA



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

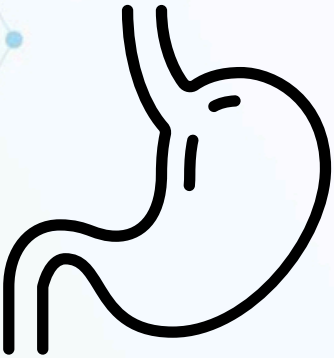
HIPOGLICEMIA GRAVE

1) Glicose 50% - administrar 40 mL, via EV, agora

2) SG 5% 500 mL – administrar via EV a 33 gts/min

3) Monitorar glicemia capilar a cada 15 min.





GASTROENTEROLOGIA

CÓLICA ABDOMINAL

OPÇÕES DE TRATAMENTO

Analgésico:

- Via oral:
  - Dipirona 500 mg – 1 a 2 cp VO 6/6h

  OU
  - Paracetamol 500 a 750 mg – 1 cp VO 6/6h

- Via parenteral:
  - Dipirona 1000 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD EV 6/6h

  OU
  - DIPIRONA 1000MG/2ML – 2 ML VIA IM

Antiespasmódico

- Via oral:
  - Escopolamina 10 mg – 1 a 2 VO 3-5x/dia

  OU
  - Escopolamina 10 mg/mL - 20 a 40 gotas VO 3-5x/dia

- Via parenteral:
  - Escopolamina 20 mg/mL – 1 a 2 mL + 9 A 18mL AD EV 3-5x/dia (Máx.: 100mg/dia)

Medicamentos compostos:

- Via oral:
  - Tropinal (dipirona 300 mg + escopolamina 6,5 mcg + hiosciamina 104 mcg + homatropina 1 mg) – 1 a 2 cp VO 8/8h

  OU
  - Buscopan composto (escopolamina 10 mg + dipirona 250 mg) – 1 a 2 cp VO 3-4x/dia

  OU
  - Buscoduo (escopolamina 10 mg + paracetamol 500 mg) – 1 a 2 cp VO 3x/dia por até 3 dias

- Via parenteral:
  - Escopolamina 20mg/5mL + Dipirona 2,5g/5mL – 5 mL + 15 mL AD EV 8/8h

CÓLICA ABDOMINAL



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

CÓLICA LEVE

1) Dipirona 1000 mg/2mL – Diluir 2 mL em 18 mL de AD e administrar via EV
2) Escopolamina 20mg/mL – Diluir 1 mL em 9 mL de AD e administrar via EV

CÓLICA MODERADA/INTENSA

1) Dipirona 500 mg/mL – Diluir 2 mL em 18 mL de AD e administrar via EV
2) Escopolamina 20mg/mL – Diluir 2 mL em 8 mL de AD e administrar via EV

OU

1) Escopolamina + Dipirona 20mg+2,5g/5mL – Diluir 5 mL em 15 mL de AD e administrar via EV

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Buscopan composto ---------- 1 cx
Tomar 1 a 2 comprimido(s), via oral, de 8/8h, se cólica abdominal.



CONSTIPAÇÃO

OPÇÕES DE TRATAMENTO

Via oral:

- Psyllium em pó – Diluir 1 a 2 colheres de sopa em um copo de água ou suco e tomar, via oral, 2 vezes por dia

OU Lactulose 667 mg/mL – Tomar 10 a 20 mL, via oral, 3 vezes por dia

OU
- Bisacodil 5 mg – Tomar 01 comprimido, via oral, à noite

Via retal:

- Minilax (Sorbitol 714mg/g + Lurilsulfato de sódio 7,7 mg/g) – Aplicar todo o conteúdo da bisnaga via retal

OU Enema de glicerina 12% (Clister Glicerinado) 500 mL – Aplicar o
- conteúdo de 1 frasco via retal



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Enema de glicerina 12% - aplicar o conteúdo de 1 frasco via retal

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Lactulose 667 mg/mL ---------- 1fr

Tomar 15 mL, via oral, de 8/8h, se constipação.



DIARREIA AGUDA (GECA)

ESQUEMA DE TRATAMENTO

PARA TODO PACIENTE

Hidratação:

Tomar líquidos caseiros (água, chá, suco, água de coco, sopas) ou sais de reidratação oral (SRO) - pelo menos 200 mL, via oral - a cada evacuação diarreica.

Opções de SRO:

- Hidralyte 500 mL - tomar pelo menos 200 mL, via oral, a cada evacuação diarreica

OU

- Hidraplex pó para solução oral – diluir o conteúdo de 1 sachê em 1 litro de água filtrada ou fervida e tomar pelo menos 200 mL, via oral, a cada evacuação diarreica

Durante o período de diarreia, Evitar alimentos contendo lactose (leite e derivados) ou cafeína

SINTOMÁTICOS

Antidiarreicos:
(evitar se fezes com sangue/muco, febre, distensão do cólon, número de evacuações > 6-10/24h, comprometimento do estado geral)

- Loperamida 2 mg – 2 cp, VO, após a primeira evacuação, seguido de 1 cp VO após cada evacuação. Utilizar por até 2 dias. Máx.: 8 cp/dia

OU

- Racecadotrila 100 mg – 1 cp, VO, de 8/8h, por 2 a 3 dias

Att.: Loperamida é contraindicado na pediatria



DIARREIA AGUDA (GECA)

ESQUEMA DE TRATAMENTO

Probióticos:
(eficácia não comprovada em adultos)

- Floratil AT 250 mg – 1 cp, VO, de 12/12h

OU Repoflor 250 mg – 1 cp, VO, de 12/12h

-

ANTIMICROBIANOS

Se sinais de disenteria:
(fezes com sangue/muco, febre, distensão do cólon)

- Ciprofloxacino 500 mg 1 cp, VO, 12/12h, por 3 dias

Se suspeita/confirmação de giardíase ou amebíase:

- Metronidazol 250 mg/cp - 2 cp, VO, de 8/8h, por 5 dias (giardíase) a 10 dias (amebíase)

DIARREIA AGUDA (GECA)



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Hidraplex pó para solução oral ---------- 1 cx Diluir o conteúdo de 1 sachê em 1 litro de água filtrada ou fervida e tomar,
pelo menos 200 mL, via oral, a cada evacuação diarreica.

2) Ondansetrona 4 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, se náusea ou vômito.

3) Buscopan composto ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, se cólica abdominal.

Aumentar a ingesta de líquidos caseiros (água, chá, suco, água de coco, sopas)
Evitar alimentos contendo lactose ou cafeína **Se sinais de disenteria:**
4) Ciprofloxacino 500 mg ---------- 6 cp
Tomar 1 comprimido, via oral, de 12/12h, por 3 dias. Se sinas de giardíase:
5) Metronidazol 250 mg ---------- 10 cp
Tomar 2 comprimidos, via oral, de 8/8h, por 5 dias.

DISPEPSIA/EPIGASTRALGIA



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Buscopan composto (20 mg + 2,5 mg/5mL) – diluir 5 mL em 15 mL de AD e administrar via EV

2) Bromoprida 10 mg/2mL – diluir 2 mL em 18 mL de AD e administrar via EV
OU
2) Metoclopramida 10 mg/2 mL – diluir 2 mL em SF0,9% 50 mL e administrar via EV em 15 min

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Omeprazol 20 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 cp, via oral, 30 minutos antes do café, por 1 mês.

2) Digeplus (Metoclopramida 7 mg + Dimeticona 40 mg + Pepsina 50 mg) ---------- 1 cx

Tomar 1 a 2 comprimido(s), via oral, antes das principais refeições, se epigastralgia (dor no estômago) ou sensação de plenitude gástrica.

OU

1) Omeprazol 20 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, 30 minutos antes do café, por 1 mês.

2) Domperidona 10 mg ---------- 01 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, 30 minutos antes das refeições, se epigastralgia (dor no estômago) ou sensação de plenitude gástrica



NÁUSEA/VÔMITO

OPÇÕES DE TRATAMENTO

Via oral:

- Metoclopramida 10 mg – 1 cp, VO, de 8/8h

OU Bromoprida 10 mg – 1 cp, VO, de 8/8h

- OU Ondansetrona 4-8mg – 1 cp, VO, de 8/8h

OU Dramin B6 (Dimenidrinato 50 mg + Piridoxina 10 mg) – 1 a 2 cp, VO, de

- 6/6h

Via parenteral:

- Metoclopramida 10 mg/2 mL – 2 mL + SF0,9% 50 mL EV em 15 min

OU Bromoprida 10 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD EV em 3-5 min

- OU Ondansetrona 4 mg/2mL – 2 mL EV em 2-5 min

OU Ondansetrona 8 mg/4mL – 4 mL + SF0,9% 50 mL EV em 15 min

- OU Dramin B6 DL 10 mL – 10 mL + SF0,9% 10 mL EV em 2 min



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Bromoprida 10mg/2mL – diluir 2 mL em 18 mL de AD e administrar via EV lento

NÁUSEA/VÔMITO

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Metoclopramida 10 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, se náusea ou vômito.

PIROSE

OPÇÕES DE TRATAMENTO

- Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL – agitar bem o frasco e diluir 10-15 mL (1 colher de sopa) em meio copo de água e tomar via oral 1 hora após as refeições

OU

- Hidróxido de magnésio 80 mg/mL – agitar bem o frasco e tomar 10-15 mL (1 colher de sopa) até 3 vezes por dia

ASSOCIAÇÕES:

- Gastrogel suspensão oral – agitar bem o frasco e tomar 10-20 mL VO 2 vezes por dia

OU

- Gastrogel comprimido – mastigar 2 comprimidos até 4 vezes por dia

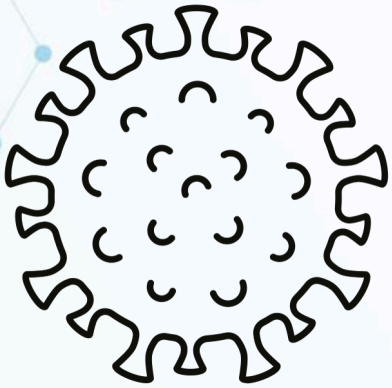


PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL ---------- 1 cx

Agitar bem o frasco e tomar 10 a 15 mL, diluído em meio copo de água, 1 hora após as refeições, se sensação de azia, má digestão.





INFECTOLOGIA

PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO (PEP)



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO E NO AMBULATÓRIO

1) Tenofovir/Lamivudina (TDF/3TC) 300 mg/300 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, 1 vez por dia, por 28 dias.

2) Dolutegravir (DTG) 50 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, 1 vez por dia, por 28 dias.

OBS: Os comprimidos devem ser tomados juntos.

Att: A PEP deve ser iniciada o mais precoce possível, tendo como limite as 72 horas subsequentes à exposição de risco.

TUBERCULOSE

ESQUEMA DE TRATAMENTO

FASE INTENSIVA (2 MESES)

- RHZE 150/75/400/275 mg

FASE DE MANUTENÇÃO (4 MESES)

- RH 150/75 mg

R: Rifampicina
H: Isoniazida
Z: Pirazinamida
E: Etambutol

TUBERCULOSE

ESQUEMA	PESO	CP/DOSE	DURAÇÃO
RHZE 150/75/400/275mg	20-35 kg	2 cp	Fase Intensiva 2 meses
	36-50 kg	3 cp	
	51-70 kg	4 cp	
	>70 kg	5 cp	
RH 150/75 mg	20-35 kg	2 cp	Fase de Manutenção 4 meses
	36-50 kg	3 cp	
	51-70 kg	4 cp	
	>70 kg	5 cp	



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO E NO AMBULATÓRIO

Ex: Paciente 55 kg

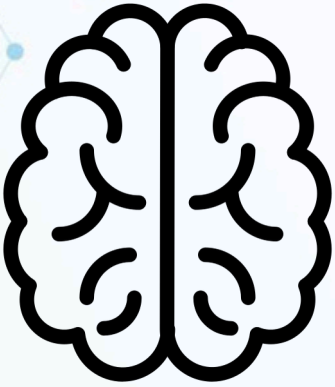
1) RHZE 150/75/400/275 mg ---------- FASE INTENSIVA

Tomar 4 comprimidos, via oral, 1 vez por dia em jejum (30 minutos antes do café), por 2 meses. Após os 2º mês, seguir com fase de manutenção por mais 4 meses.

2) RH 150/75 mg ---------- FASE DE MANUTENÇÃO

Tomar 4 comprimidos, via oral, 1 vez por dia em jejum (30 minutos antes do café), por 4 meses.

Tempo total do tratamento: 6 meses



NEUROLOGIA

AVC ISQUÊMICO COM INDICAÇÃO DE TROMBÓLISE



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

SE INDICAÇÃO PARA TROMBÓLISE: SEGUIR O PROTOCOLO DA INSTITUIÇÃO E OFERECER O SUPORTE CLÍNICO INICIAL ABAIXO NA PRIMEIRA HORA:

1) Dieta oral zero

2) Dipirona 500 mg/mL – administrar 2 mL + 18 mL AD via EV, se TAX ≥ 37,5 °C

3)* Nitroprussiato 50mg/2mL – Diluir 2 mL em SG 5% 248 mL e administrar via EV em BIC a 5-10 mL/h, se PA > 185x110 (aferir PA a cada 5 min e ajustar vazão em 2 mL/h, se necessário – MÁX: 45 mL/h)

4) Glicemia capilar (DX alvo: 140-180)

5) Insulina Regular, se DX ≥ 180 mg/dL – Administrar via SC conforme Glicemia Capilar: 181-200: 2 UI; 201-250: 4 UI; 251-300: 6UI; 301-350: 8UI; 351-400: 10 UI; ≥ 400: 12 UI

6) Glicose 50% – Administrar 20 mL via EV, se glicemia capilar ≤ 70 mg/dL, repetir DX após 15 minutos

7) Aferir PA a cada 15 min na primeira hora (PA Alvo < 160-185x110 mmHg)

8) Monitoramento cardíaco não invasivo

9) Suplementação de O2, se SATO2 < 95%

*OUTRAS OPÇÕES PARA ANTI-HIPERTENSIVO (ITEM 3)

3) Esmolol 2500 mg/10mL – Diluir 10 mL em SF0,9% 240 mL e administrar 3,5 mL via EV bolus em 1 minuto. Manter a solução restante em BIC a 20 mL/h (aferir PA a cada 4 minutos e, se necessário, administrar bolus de 3,5 mL e aumentar a vazão em 21 mL/h – MÁX: 84 mL/h)

3) Metoprolol 5mg/5mL – Administrar 5 mL EV em 5 min (aferir PA a cada 10 min e, se necessário, administrar 5 mL – MÁX: 20 mg (20 mL)
3) Hidralazina injetável 20 mg/mL – diluir 1 mL em 9 mL SF0,9% e administrar 2,5 mL via EV, se PA ≥ 185x110 mmHg (se necessário, repetir a cada 15 minutos por até 3 vezes)

PRESCRIÇÃO DO TROMBOLÍTICO (ALTEPLASE – rtPA)

Administrar rtPA EV (0,9mg/kg, no máximo 90mg), com 10% da dose total em bolus inicial, seguido da infusão do restante em 60 minutos.

A diluição do rtPA é de 1mg/mL (o diluente vem junto da apresentação).

Deve-se utilizar AVP exclusivo para trombólise puncionado em membro superior.

Alteplase – tabela com o volume de administração de acordo com o peso do paciente:

PESO (KG)	VOLUME BOLUS (ML)	VOLUME EM 1 H (ML)
40	3,6	32,4
45	4,05	36,45
50	4,5	40,5
55	4,95	44,55
60	5,4	48,6
65	5,85	52,65
70	6,3	56,7
75	6,75	60,75
80	7,2	64,8
85	7,65	68,85
90	8,1	72,9
95	8,55	76,95
100 ou mais	9	81

SE PIORA NEUROLÓGICA DURANTE ADMINISTRAÇÃO DO TROMBOLÍTICO, INTERROMPER SUA ADMINISTRAÇÃO E REALIZAR NOVA TC DE CRÂNIO

AVC ISQUÊMICO COM INDICAÇÃO DE TROMBÓLISE

PRESCRIÇÃO DO TROMBOLÍTICO (ALTEPLASE – rtPA)

Exemplo em paciente de 70 kg:
1) Alteplase 1mg/mL – administrar 6,3 mL via EV em bolus, seguido de 56,7 mL via EV em BIC em 1 hora

AVC ISQUÊMICO SEM INDICAÇÃO DE TROMBÓLISE



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

Prescrição para paciente com quadro de AVC Isquêmico (fase aguda), fora da janela para trombólise ou sem trombólise disponível no serviço:

1) Dieta oral zero até avaliação da capacidade de deglutição
2) Enoxaparina 40 mg/0,4mL – administrar 0,4 mL via SC a cada 24h
3) AAS 100 mg/cp – 3 cp, VO/SNE na admissão, seguido de 1 cp a cada 24h
4) Sinvastatina 40 mg/cp – administrar 1 cp, VO/SNE, a cada 24h
5) Glicemia capilar (DX alvo: 140-180)
6) Insulina Regular, se DX ≥ 180 mg/dL – Administrar via SC conforme Glicemia Capilar: 181-200: 2 UI; 201-250: 4 UI; 251-300: 6UI; 301-350: 8UI; 351-400: 10 UI; ≥ 400: 12 UI
7) Glicose 50% – Administrar 20 mL EV, se glicemia capilar ≤ 70 mg/dL, repetir DX após 15 minutos
8) Dipirona 500 mg/mL – 2 mL + 18 mL AD EV, se TAX ≥ 37,5 °C
9) Nitroprussiato 50mg/2mL – Diluir 2 mL em SG5% 248 mL e administrar EV em BIC a 5-10 mL/h, se PA > 220x120 (aferir PA a cada 5 min e ajustar vazão em 2 mL/h, se necessário – MÁX: 45 mL/h) – PA permissiva nas primeiras 48h

CEFALEIA PRIMÁRIA MIGRÂNEA (ENXAQUECA)

ESQUEMA DE TRATAMENTO

- Analgésico simples, podendo ser associado a AINE
- Dexametasona, se duração do quadro >48h
- Antiemético, se náusea
- Triptano, se refratariedade



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

DOR MODERADA/INTENSA

1) Dipirona 1g/2mL – 2 mL + 18 mL AD EV
2) Cetoprofeno 100 mg/fr – 1 fr + SF0,9% 100 mL EV em 30 min
3) Dexametasona 4 mg/mL – 2,5 mL + 17,5 mL AD EV

Se náusea:
4) Bromoprida 10 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD EV

DOR REFRATÁRIA A ANALGESIA INICIAL

1) Sumatriptano 6 mg/0,5mL – Administrar 0,5 mL via SC

OU

1) Clorpromazina 25 mg/5mL – Administrar 2 mL via IM

CEFALEIA PRIMÁRIA
MIGRÂNEA (ENXAQUECA)

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Dipirona 500 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 a 2 comprimidos, via oral, de 6/6h, se dor

2) Ibuprofeno 400 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, por até 5 dias seguidos, se dor intensa.

3) Ondansetrona 4 mg ---------- 1 cx

Tomar 01 comprimido, via oral, de 8/8h, se náusea ou vômito.

4) Sumatriptano 50 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, a cada 2h (máx: 4 cp/dia), se dor de cabeça refratária a analgesia inicial (itens 1 e 2) ou se dor muito intensa.

Manter repouso em ambiente escuro e calmo associado a compressa gelada em região lateral da testa (região temporal) por 20 minutos.

Outras opções de triptanos:

- Sumatriptano 50 mg – 1 cp, VO, a cada 2h (Máx: 4 cp)

OU Zolmitriptano 2,5 mg – 1 cp, VO, a cada 2h (Máx: 4 cp)

OU

- Rizatriptana 10 mg – 1 cp, VO, a cada 2h (Máx: 3 cp)

CEFALEIA PRIMÁRIA TENSIONAL

ESQUEMA DE TRATAMENTO

- Analgésico simples
+ AINE
-



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Dipirona 1g/2mL – 2 mL + 18 mL AD EV

2) Cetoprofeno 100 mg/fr – 1 fr + SF0,9% 100 mL EV em 30 min

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Paracetamol 750 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 6/6h, se dor.

2) Diclofenaco 50 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, por até 5 dias seguidos, se dor intensa.

CRISE CONVULSIVA

OPÇÕES DE TRATAMENTO

- Diazepam 10mg/2mL – 2 mL via EV – repetir a cada 3-5 min, se nova crise (MÁX: 30 mg)

Se acesso venoso indisponível:

- Midazolam 5 mg/mL – 2 mL via IM ou via nasal - dose única

(Dose: 0,2 mg/kg – Máx.: 10mg)

OU

- Diazepam 10mg/2mL – 4 mL via retal



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Diazepam 10 mg/2mL – administrar 2 mL via EV

STATUS DE MAL EPILÉPTICO

- Fenitoína 250 mg/5mL – diluir 20 mL em SF0,9% 250 mL e administrar via EV em 20-30 min, se persistência das crises refratárias a diazepam ou estado de mal epiléptico (crise ≥ 5 min)

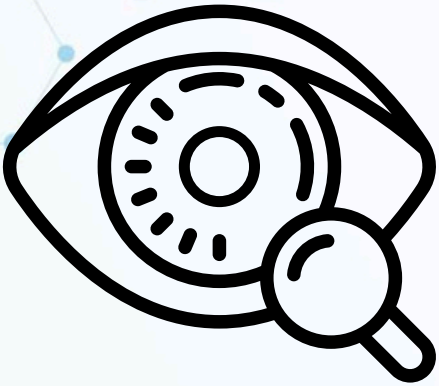
  (Dose: 15-20 mg/kg)



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Fenitoína 250 mg/5mL – diluir 20 mL em SF0,9% 250 mL e administrar via EV em 20-30 min.





OFTALMOLOGIA

HORDÉOLO

ESQUEMA DE TRATAMENTO

- ·Tobradex (Tobramicina + Dexametasona 3 mg + 1mg/g) pomada oftálmica – aplicar fina camada em saco conjuntival 3x/dia por 5 dias

OU

- ·Maxiflox D (Ciprofloxacino + Dexametasona 3,5 mg + 1mg/g) pomada oftálmica – aplicar fina camada em saco conjuntival 3x/dia por 5 dias

+

- ·Compressa morna – aplicar calor úmido em local afetado por 5 a 10 minutos, 3 a 5 vezes por dia

+

- ·Massagem - realizar leve massagem/compressão local, após aplicação da compressa morna, para drenar lesão



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Tobradex pomada oftálmica ---------- 1 bisnaga

Aplicar fina cama em saco conjuntival, 3 vezes por dia, por 5 dias.

Compressa morna + massagem

Aplicar calor úmido em local afetado, por 5 a 10 minutos, 3 a 5 vezes por dia. Após compressa, realizar massagem suave no local.



CONJUNTIVITE VIRAL



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Ecofilm colírio ---------- 1fr

Aplicar 1 a 2 gotas em olho afetado, 3 a 4 vezes por dia. Manter colírio em geladeira.

Compressa gelada + lavagem dos olhos

Aplicar compressa gelada por 15 minutos, 4 vezes por dia.

Lavar abundantemente os olhos com SF 0,9% gelado para alívio dos sintomas.

CONJUNTIVITE BACTERIANA

OPÇÕES DE TRATAMENTO

- Ofloxacina (Oflox) 0,3% solução oftálmica - 1 gota em olho afetado, de 6/6 h, por 7 dias.

OU

- Tobramicina (Tobrex) 0,3% solução oftálmica - 1 gota em olho afetado, de 6/6 h, por 7 dias.



CONJUNTIVITE BACTERIANA



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Ofloxacina 0,3 % solução oftálmica ---------- 1 bisnaga

Aplicar 1 gota em olho afetado, de 6/6h, por 7 dias.

Lavagem dos olhos

Lavar os olhos com SF 0,9% gelado para higiene das pálpebras e dos cílios.





ORTOPEDIA

DOR LOMBAR MECÂNICA

ESQUEMA DE TRATAMENTO

Escolha uma classe de medicamentos ou associações entre elas.
Cada paciente pode responder de forma individual a cada terapêutica instituida.

Analgésico comum:

- Via oral
  - Dipirona 500 mg/cp – 1 a 2 cp, VO, de 6/6h
  - Paracetamol 750 mg/cp – 1 cp, VO, de 6/6h

- Via parenteral
  - Dipirona injetável 1g/2mL – 2 mL + 18 mL AD EV 6/6h
  - Dipirona injetável 1g/2mL – 2 mL via IM

Anti-inflamatório não esteroidal (AINE):

- Via oral
  - Diclofenaco 50 mg/cp – 1 cp, VO, 8/8h, por até 5 dias
  - Ibuprofeno 400 mg/cp – 1 cp, VO, 8/8h, por até 5 dias
  - Tenoxicam 20 mg/cp – 1 cp, VO, 1 vez por dia, por até 5 dias
  - Cetorolaco 10 mg/cp – 1 cp, via sublingual, 1 vez por dia, ou de 8/8h, por até 5 dias

- Via parenteral
  - Cetoprofeno 100mg/fr – 1 fr + SF0,9% 100 mL EV em 30 min (12/12h)
  - Cetoprofeno 100mg/2mL – 2 mL via IM
  - Tenoxicam 20mg/fr – 1 fr + 2 mL AD EV lento (1 vez por dia)
  - Diclofenaco 75 mg/3mL – 3 mL IM
  - Cetorolaco 30mg/mL – 0,5 mL a 1 mL via EV em bolus

DOR LOMBAR MECÂNICA

ESQUEMA DE TRATAMENTO

Relaxante muscular:

- Via oral
  - Ciclobenzaprina 5 mg/cp – 1 cp VO 8/8h

- Via parenteral
  - Tiocolchicosídeo 4 mg/2mL – 2 mL via IM 12/12h por até 5 dias

Associações:

- Paracetamol 300 mg + Diclofenaco 50 mg + Carisoprodol 125 mg + cafeína 30 mg
  - Tandene - 1 cp, VO, 12/12h, por até 7 dias seguidos
  - Trimusk - 1 cp, VO, 12/12h, por até 7 dias seguidos
  - Torsilax - 1 cp, VO, 12/12h, por até 7 dias seguidos
  - Mioflex A - 1 cp, VO, 12/12h, por até 7 dias seguidos

Opioide:

- Via oral (receita controle especial)
  - Codeína 30 mg/cp – 1 cp, VO, 6/6h
  - Tramadol 50 mg/cp – 1 cp, VO, 6/6h

  Associações
  - Paracetamol 500 mg + Codeína 30 mg - 1 cp, VO, 4/4h
  - Paracetamol 325 mg + Tramadol 37,5 mg - 1 cp, VO, 4/4h

- Via parenteral
  - Tramadol 50mg/mL (ampola com 1 mL e 2 mL) – 2 mL + SF0,9% 100 mL EV em 30 min
  - Tramadol 50 mg/mL – 1 a 2 mL via IM

Orientações gerais

- Repouso absoluto é contraindicado
- Compressa morna em por 20 min, em local afetado, 4 vezes por dia
- Correção postural e ergonômica

DOR LOMBAR MECÂNICA



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Dipirona 1000 mg/2mL – 2 mL + 18 mL AD via EV
2) Diclofenaco 75 mg/3mL – 3 mL via IM
3) Tiocolchicosídeo 4 mg/2mL – 2 mL via IM
Se dor muito intensa, ou refratariedade:
1) Tramadol 50 mg/mL – 2 mL + SF0,9% 100 mL via EV

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Paracetamol 750 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 6/6h, se dor.

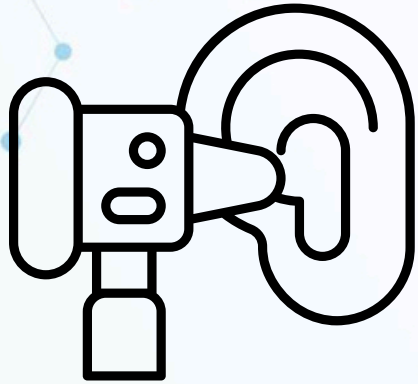
2) Ibuprofeno 400 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, por até 5 dias seguidos, se dor intensa.

3) Ciclobenzaprina 5 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, por até 5 dias.

Aplicar compressa morna por 20 minutos, em local afetado, 4 vezes por dia.



OTORRINOLARINGOLOGIA

CERUME IMPACTADO

OPÇÕES DE TRATAMENTO

- Cerumin (Hidroxiquinolina + trolamina 0,4 + 140 mg/mL) – pingar 5 gotas em ouvido afetado e deixar agir por 5 minutos. Aplicar de 8/8h por 5-7 dias

OU

- Aceratum (Peróxido de carbamida 100 mg/mL) – pingar 5 gotas em ouvido afetado de 12/12h por até 4 dias consecutivos

OU

- Oticerim (Peróxido de ureia 100 mg/mL) – pingar 5 gotas em ouvido afetado 8/8h por 4 dias



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Cerumin ---------- 1 cx

Pingar 5 gotas em ouvido afetado e deixar agir por 5 minutos. Aplicar de 8/8h por 5-7 dias.

Após 5-7 dias, retornar para reavaliação médica e lavagem otológica.



FARINGOAMIGDALITE ESTREPTOCÓCICA



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Penicilina G benzatina 1.200.000 unidades – reconstituir 1 fr em 4 mL de AD e administrar via IM, dose única.

(para ≤ 27 kg: 600.000 unidades)

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Amoxicilina 500 mg ---------- 30 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h por 10 dias.

OTITE EXTERNA

OPÇÕES DE TRATAMENTO

- Otociriax (ciprofloxacino + hidrocortisona 2+10mg/mL) – 3 gts no canal auditivo afetado, de 12/12h, por 7 dias. Ciprofloxacino solução

OU otológica 3 mg/mL – 3 gts no canal auditivo afetado, de 12/12h, por 7

- dias. Elotin (fluocinolona + neomicina + polimixina B + lidocaína 0,275 mg + 3,85 mg + 11.000 UI + 20 mg/mL) - 3 gts no canal auditivo afetado,

OU de 8/8h, por 7 dias.

-



OTITE EXTERNA



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Elotin solução otológica ---------- 01 fr

Instilar 3 gotas no canal auditivo afetado (deixar agir por 30 segundos), de 8/8h, por 7 dias.

#Manter canal auditivo limpo e seco. Proteger ouvido afetado com algodão embebido em óleo durante o banho.

PARALISIA DE BELL

ESQUEMA DE TRATAMENTO

1) Corticoterapia

- Prednisona ou Prednisolona: 60 mg/dia por 5 dias, seguido de 10 mg/dia por mais 5 dias OU 60 mg/dia por 7 dias.

2) Lubrificação ocular

- Carmelose sódica 0,5% (Ecofilm) – pingar 1-2 gotas em olho afetado 4 a 6 vezes por dia

3) Antiviral (se sintomas severos)

- Aciclovir 400 mg VO 5x/dia por 10 dias

OU Valaciclovir 1000 mg VO 3x/dia por 7 dias

-



PARALISIA DE BELL



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Predinisona 20 mg ---------- 25 cp

Tomar 3 comprimidos, via oral, por 5 dias, seguido de ½ comprimido, via oral, por mais 5 dias.

2) Carmelose sódica 0,5% ---------- 1fr

Pingar 1 gota em olho afetado 4 a 6 vezes por dia

3) Aciclovir 400 mg ---------- 50 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, de 4/4h, por 10 dias. Não tomar a dose da madrugada.
Sugestão de horário: 6h, 10h, 14h, 18h, 22h

RINITE ALÉRGICA INTERMITENTE



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Bilastina 20 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, uma vez por dia (uma hora antes ou 2 horas após a refeição), enquanto persistirem sintomas.

2) SF 0,9% ---------- 1 fr

Realizar lavagem nasal com solução fisiológica 3 vezes ao dia.



RINITE ALÉRGICA PERSISTENTE



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Bilastina 20 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, uma vez por dia (uma hora antes ou 2 horas após a refeição), enquanto persistirem sintomas.

2) Mometasona 50 mcg spray ---------- 1 un

Aplicar 1 a 2 jatos em cada narina, 1 vez por dia, por 30 dias.

3) SF 0,9% ---------- 1 fr

Realizar lavagem nasal com 20 mL de solução fisiológica 3 vezes ao dia.

RINOSSINUSITE BACTERIANA

OPÇÕES DE TRATAMENTO

- Amoxacilina 500mg – 1 cp VO de 8/8h por 7 dias

OU Amoxacilina-Clavulanato 875/125mg – 1 cp VO de 12/12h por 7 dias

OU Levofloxacino 500mg – 1 cp VO 1x/dia por 7 dias

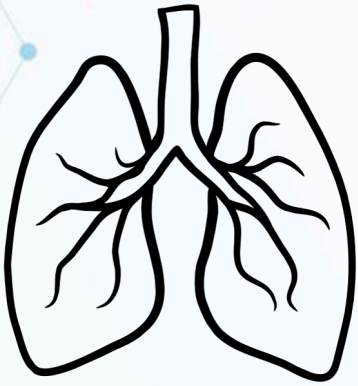
RINOSSINUSITE BACTERIANA



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Amoxicilina-Clavulanato 875/125mg ---------- 14 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, de 12/12h, por 7 dias



PNEUMOLOGIA

CRISE ASMÁTICA



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Salbutamol aerossol 100 mcg/dose – inalar 4 a 10 jatos em 3 etapas (uma a cada 20 minutos na primeira hora), seguido de 4 a 10 jatos a cada hora, até melhora clínica
(Começar com 4 jatos e ajustar +2 jatos em cada etapa, se necessário)
2) Ipratrópio 0,25 mg/mL - nebulizar 40 gotas com SF 0,9% 5 mL em 3 etapas (uma a cada 20 minutos na primeira hora), seguido de 1 etapa a cada hora, até melhora clínica
3) Prednisona ou Prednisolona 20 mg – 2 a 3 cp VO agora
OU
3) Hidrocortisona 100 mg/fr – diluir 2 fr em SF0,9% 50 mL e administrar via EV em 15 min
OU
3) Metilprednisolona 125 mg/2mL – diluir 1 mL em SF0,9% 50mL e administrar via EV
4) Oxigênio suplementar, se SatO2 < 92%

PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL (APÓS ALTA DO PS)

1) Salbutamol aerossol 100 mcg/dose ---------- 1 un

Inalar 8 jatos a cada 20 minutos, se exacerbação do quadro. Utilizar medicamento de resgate por até 7 dias.
Na ausência de melhorar, procurar serviço de urgência e emergência

2) Prednisona 20 mg ---------- 10 cp

Tomar 2 comprimidos, via oral, 1 vez por dia, pela manhã, por 5 dias

Manter medicações de controle e retornar ao ambulatório para avaliar ajuste do tratamento



PNEUMONIA

OPÇÕES DE TRATAMENTO AMBULATORIAL

PACIENTE SEM COMORBIDADES

- Amoxicilina 500mg – 2 cp VO 8/8h por 7 dias

OU Amoxicilina-Clavulanato 875/125mg – 1 cp VO 12/12h por 7 dias

OU Levofloxacino 750 mg 1 cp VO 1x/dia por 5 dias

PACIENTE COM COMORBIDADES

Associação:

- Amoxicilina-Clavulanato 875/125mg – 1 cp VO 12/12h por 7 dias
  + Azitromicina 500 mg – 1 cp VO 1x/dia por 5 dias

OU

Monoterapia:

- Levofloxacino 750 mg – 1 cp VO 1x/dia por 5 dias

OPÇÕES DE TRATAMENTO HOSPITALAR

Associação:

- Ceftriaxona 1g EV de 12/12h **OU** Cefotaxima 2g EV 8/8h **OU** Ampicilina/Sulbactam 3g EV 6/6h
  +
- Azitromicina 500 mg VO 1x/dia por 5 dias **OU** Claritromicina 500 mg EV 12/12h por 7 dias

Monoterapia:

- Levofloxacino 750 mg VO ou EV 1x/dia

PNEUMONIA



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

PACIENTE SEM COMORBIDADES:

1) Amoxicilina-Clavulanato 875/125mg ---------- 14 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, de 12/12h, por 7 dias.

PACIENTE COM COMORBIDADES:

1) Amoxicilina-Clavulanato 875/125mg ---------- 14 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, de 12/12h, por 7 dias.

2) Azitromicina 500 mg ---------- 5 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, 1 vez por dia, por 5 dias.

PRESCRIÇÃO HOSPITALAR

1) Ceftriaxona 1 g/fr – reconstituir 1 fr em 10 mL AD e diluir em SF 0,9% 100 mL – administrar via EV em 30 min. de 12/12h por 7 dias
2) Claritromicina 500 mg/fr – reconstituir 1 fr em 10 mL AD e diluir em SF 0,9% 250 mL – administrar via EV em 60 min. de 12/12h por 7 dias





PSIQUIATRIA

AGITAÇÃO PSICOMOTORA

ESQUEMA DE TRATAMENTO

- Haloperidol 5mg/mL – 1 mL IM a cada 30 min, se necessário (Máx.: 15-30mg/dia)

Podendo ser associado a:

- Prometazina 50mg/2mL – 2 mL IM, dose única



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Haloperidol 5 mg/mL – administrar 1 mL via IM

2) Prometazina 50 mg/2mL – administrar 2 mL via IM

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA

ESQUEMA DE TRATAMENTO

ABSTINÊNCIA MODERADA

- Diazepam 10 mg VO, a cada hora, até melhora (Máx.: 4 cp - 40mg/dia)

OU Lorazepam 2 mg VO, a cada hora até melhora (Máx.: 5 cp – 10 mg/dia)

-

ABSTINÊNCIA GRAVE

- Diazepam 10 mg/2mL – 1 a 2 mL via EV a cada 10 minutos até melhora (Máx.: 4 mL – 20 mg/dia)



SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

ABSTINÊNCIA GRAVE

1) Diazepam 10 mg/2mL – administrar 2 mL via EV

CRISE DE ANSIEDADE E CRISE DE PÂNICO

OPÇÕES DE TRATAMENTO

- Alprazolam 0,25-0,5mg VO
  - Apresentação 0,25mg/cp – 1 a 2 cp VO
  - Apresentação 0,5mg/cp – ½ a 2 cp VO

OU

- Clonazepam 0,25-0,5mg VO
  - Apresentação 2,5mg/mL: - 3 a 6 gotas VO
  - Apresentação 0,5 mg/cp: 1/2 a 1 cp VO

OU

- Diazepam 5 mg VO
  - Apresentação 5 mg/cp: 1 cp VO
  - Apresentação 10 mg/cp: ½ cp VO



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Clonazepam 2,5 mg/mL – administrar 5 gotas via oral





UROLOGIA

CÓLICA NEFRÉTICA

OPÇÕES DE TRATAMENTO

Analgesia simples + AINE

- Dipirona 1 g/2mL – 2 mL + 18 mL AD EV

OU Paracetamol 500 mg/cp – 1 cp VO

- +

OU

OU

- Diclofenaco 75mg/3mL – 3 mL IM
  Cetoprofeno 100mg/fr – 1fr + SF0,9% 100mL EV
- Cetorolaco 30mg/mL – 0,5 a 1mL EV
-

Se refratariedade:

- Tramadol 50mg/mL – 2 mL + SF0,9% 100mL EV
- Morfina 10mg/mL – 1mL + 9mL SF0,9%, administrar 2 a 5 mL EV

OU

-



PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

1) Dipirona 1 g/2mL – diluir 2 mL em 18 mL AD e administrar via EV
2) Cetoprofeno 100 mg/fr – reconstituir 1 fr em SF 0,9% 100 mL e administrar via EV em 30 minutos

Se refratariedade:
1) Tramadol 50mg/mL – 2 mL + SF0,9% 100mL via EV em 30 minutos



CISTITE
(ITU BAIXA)

OPÇÕES DE TRATAMENTO

Escolha uma opção de antibiótico:

- Nitrofurantoína 100mg – 1 cp, VO, 6/6h, por 5 dias

OU Fosfomicina 3g – conteúdo de 1 envelope, VO, dose única

OU Ciprofloxacino 500mg – 1 cp, VO, 12/12h, por 3 dias

OU Amoxicilina-Clavulanato 875-125mg – 1 cp VO 12/12h por 7 dias

OU Cefalexina 500mg – 1 cp, VO, 6/6h, por 7 dias

-
-

Analgesia:

- Fenazopiridina (Pyridium) 200mg - 1 cp, VO, 8/8h, por até 2 dias, se dor ao urinar (disúria)



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Nitrofurantoína 100 mg ---------- 20 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, de 6/6h, por 5 dias.

2) Fenazopiridina 200 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, por até dois dias, se dor ao urinar

PIELONEFRITE (ITU ALTA)

OPÇÕES DE TRATAMENTO

Via Oral

- Ciprofloxacino 500mg – 1 cp VO 12/12h por 7 dias
- Levofloxacino 750mg – 1 cp VO 1x/dia por 7 dias

Via endovenosa

- Ceftriaxona 1g EV ou IM de 24/24h por 7 dias
- Ciprofloxacino 400 mg EV de 12/12h por 7 dias



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

1) Ciprofloxacino 500 mg ---------- 14 cp

Tomar 1 comprimido, via oral, por 7 dias.

PRESCRIÇÃO HOSPITALAR

1) Ceftriaxona 1 g/fr – reconstituir 1 fr em 10 mL de AD e diluir em SF 0,9% 100 mL – administrar a solução via EV em 30 min a cada 24h



INFECÇÕES VIRAIS

DENGUE

ESQUEMA DE TRATAMENTO

Grupos A e B = acompanhamento ambulatorial

- **HIDRATAÇÃO ORAL**
  - 1/3 com Sais de Reidratação Oral (SRO);
  - 2/3 com líquidos caseiros (água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, etc.).
  - Manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24 a 48 horas, após a defervescência da febre.
    Adulto
  -
    - 60 mL/kg/dia

Tabela com quantidade em mL de SRO e líquidos caseiros para ser ingerido em 24h de acordo com o peso em kg do paciente:

Peso (kg)	SRO (mL)	Líquidos caseiros (mL)	TOTAL em 24h (mL)
40	800	1600	2400
45	900	1800	2700
50	1000	2000	3000
55	1100	2200	3300
60	1200	2400	3600
65	1300	2600	3900
70	1400	2800	4200
75	1500	3000	4500
80	1600	3200	4800
85	1700	3400	5100
90	1800	3600	5400
95	1900	3800	5700
100	2000	4000	6000



ESQUEMA DE TRATAMENTO

- **Criança**
  - Até 10 kg: 130 mL/kg/dia
  - 10 kg a 20 kg: 100 mL/kg/dia
  - > 20 kg: 80 mL/kg/dia

Tabela com quantidade em mL de SRO e líquidos caseiros para ser ingerido em 24h de acordo com o peso em kg do paciente:

Peso (kg)	SRO (mL)	Líquidos caseiros (mL)	TOTAL em 24h (mL)
5	216	434	650
10	434	866	1300
15	500	1000	1500
20	667	1333	2000
25	667	1333	2000
30	800	1600	2400
35	934	1866	2800

Grupo C = internação hospitalar em leito de enfermaria, por pelo menos 48h, até estabilização clínica e critérios de alta

Fase de expansão: Hidratação Venosa Imediata

- SF 0,9% 20mL/kg via EV em 2 horas
  - Fase de expansão pode ser repetida por até 3 vezes, se não houver melhora clínica

Fase de manutenção:

- Primeira fase:
  - SF0,9% 25 mL/kg em 6 horas. Se houver melhora, iniciar segunda fase

- Segunda fase:
  - SF 0,9% 25 mL/kg em 8 horas



DENGUE

ESQUEMA DE TRATAMENTO

Grupo D = internação hospitalar em leito de UTI, por pelo menos 48h, até estabilização clínica

- Fase de expansão rápida
  - SF 0,9% 20mL/kg via EV em 20 minutos
  - Fase de expansão rápida pode ser repetida por até 3 vezes, se não houver melhora clínica
  - Se melhora, seguir com fase de expansão do Grupo C

Se resposta inadequada, avaliar hematócrito

- Hematócrito em elevação = Albumina 0,5-1g/kg - preparar solução de albumina 5% e administrar EV a 3 mL/kg/h (para cada 100 mL desta solução, usar 25 mL de albumina a 20% e 75 mL de SF a 0,9%)
  - Ex: Paciente 70 kg (0,5g/kg) - Albumina 5% - diluir 175 mL de Albumina 20% em SF 0,9% 525 mL e administrar via E

- Hematócrito em queda
  - Persistência do choque?
    - Sim = investigar hemorragia e coagulopatia de consumo
    - Não = avaliar sinais de gravidade como: sinais de desconforto respiratório, sinais de ICC e investigar hiperhidratação

Se reposta adequada, tratar como grupo C

- Interromper ou reduzir a infusão de líquidos à velocidade mínima necessária se: Houver término do extravasamento plasmático; Normalização da PA, do pulso e da perfusão periférica; Diminuição do hematócrito, na ausência de sangramento; Diurese normalizada; Resolução dos sintomas abdominais.

ATENÇÃO: pacientes idosos ou na presença de comorbidades, como as cardiopatias e insuficiência renal, precisam adequar os volumes de hidratação caso a caso, evitando sobrecargas de volume.



DENGUE



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

GRUPO A E GRUPO B

Paciente 70 kg:

1) Dipirona 500 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 cp, via oral, de 6/6h, se dor ou febre.

2) Bromoprida 10 mg ---------- 1 cx

Tomar 1 cp, via oral, de 8/8h, se náusea ou vômito.

Ingerir 4200 mL de líquido por dia, sendo:

- 1400 mL de Soro de Reidratação Oral
- 2800 mL com líquidos caseiros (água, soro caseiro, suco de frutas, água de coco, chás, etc)

- Manter hidratação durante todo o período febril e por 24-48h após o desaparecimento da febre
- Não utilizar AAS ou outros anti-inflamatórios
- Procurar imediatamente o serviço de urgência na presença de sinais de alarme

SINAIS DE ALARME:

• Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua.
• Vômitos persistentes.
• Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico).
• Hipotensão postural e/ou lipotimia.
• Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal.
• Sangramento de mucosa.
• Letargia e/ou irritabilidade.
• Aumento progressivo do hematócrito.



DENGUE

PRESCRIÇÃO NO PRONTO SOCORRO

GRUPO C

Paciente 70 kg:

Fase de expansão – 2h:

1) SF 0,9% 1400 mL via EV em BIC 700 mL/h

Fase de manutenção – primeira fase – 6h:

1) SF 0,9% 1750 mL via EV a 97gts/min

Fase de manutenção – segunda fase – 8h:

1) SF 0,9% 1750 mL via EV a 73 gts/min

GRUPO D

Paciente 70 kg:

Fase de expansão rápida – 20 min.:

1) SF 0,9% 1400 mL via EV em 20 minutos

Se resposta inadequada e hematócrito em elevação:

1) Albumina 20 % 175 mL + SF 0,9% 525 mL - administrar via EV a 210 mL/h



RESFRIADO

ESQUEMA DE TRATAMENTO

Analgesia/Febre: cefaleia, febre ou estado febril, mialgia, otalgia, odinofagia - ESCOLHA UMA OPÇÃO

- Dipirona 500 mg – 1 cp VO 6/6h
- Paracetamol 500 mg – 1 cp VO 6/6h
- Ibuprofeno 400 mg – 1 cp VO 8/8h

Coriza, espirro, congestão nasal: - ESCOLHA UMA OPÇÃO

- **Via oral:**
  - Decongex Plus (bronfeniramina + fenilefina 12+15mg/cp) - 1 cp VO 12/12h
  - Descon (bronfeniramina + fenilefina 2+5mg/5mL) – 10 mL VO 6/6h
- **Via nasal:**
  - Rilan Nasal 2% (cromoglicato de sódio spray nasal) - 2 aplicações em cada narina 4x/dia
- **Via inalatória:**
  - Brometo de ipratrópio 0,25mg/mL: NBZ com 20-40 gts + SF0,9% 5 mL 3x/dia
- **Combinações (Analgésico + Anti-histamínico + Descongestionante):**
  - Benegripe (dipirona 500 mg+ clorfeniramina 2 mg + cafeína 30 mg) - 1 dose (1 cp verde + 1 cp amarelo) VO de 6/6h
  - Cimegripe OU Gripalcê OU Resfenol OU Fluviral (paracetamol 400 mg + clorfeniramina 4 mg + fenilefrina 4 mg) – 1 cp VO 6/6h
  - Coristina D (AAS 400 mg + Dexclorfeniramina 10 mg + cafeína 30 mg) – 1 cp VO 6/6h



RESFRIADO

Odinofagia (Faringite; Amigdalite): - ESCOLHA UMA OPÇÃO

- **Pastilhas:**
  - Ciflogex (benzidamina 3 mg/pastilha) – dissolver 1 pastilha na boca, se desconforto em garganta
    (máx.: 10 pastilhas/dia)
  - Strepsils (flurbiprofeno 8,75 mg/pastilha) – dissolver 1 pastilha na boca, a cada 3-6h, se desconforto em garganta
    (máx.: 5 pastilhas/dia)
  - Neopiridin (benzocaína 10 mg + cetilpiridínio 1,46 mg/pastilha) - dissolver 1 pastilha na boca, se desconforto em garganta
    (máx.: 06 pastilhas/dia)

- **Comprimidos:**
  - Ibuprofeno 400 mg/cp – 1 cp VO 8/8h
  - Paracetamol 500 mg/cp – 1 cp VO 6/6h
  - Dipirona 500 mg/cp – 1 cp VO 6/6h

TOSSE

(pouca evidência – não apresentam benefícios – grau de recomendação D; nível de evidência 5D): - ESCOLHA UMA OPÇÃO

- **Tosse seca (antitussígenos):**
  - Dropropizina 3mg/ml – 10 mL VO de 8/8h
  - Cloperastina 3,54mg/ml – 10 mL VO de 8/8h
  - Levodropropizina 30 mg/5mL - 10 mL VO de 8/8h



RESFRIADO

- **Tosse produtiva (expectorante)**
  - Guaifenesina 200mg/15mL – 10mL VO de 6/6h
    Ambroxol 30mg/5mL – 5 mL VO de 8/8h
  - Xarope de Guaco – 10 mL VO de 8/8h
  -

- **Tosse produtiva (mucolítico)**
  - Acetilcisteína xarope 40 mg/mL – 15 mL VO antes de dormir
    Carbocisteína 50mg/mL – 5 mL VO de 8/8h
  - Bromexina 8mg/5mL – 5 mL VO de 8/8h
  -

- **Combinações:**

Expectorante + antitussígeno:
  - Vick 44E (guaifenesina + dextrometorfano 13,33+1,33 mg/mL) - 15 mL VO de 6/6h

Tosse seca
  - Expec (cloridrato de oxomemazina + iodeto de potássio + benzoato de sódio + guaifenesina 2+100+20+30 mg/5mL) - 5 mL VO de 4/4h
    Hytós (clobutinol + doxilamina 4+0,75mg/mL) – 10 mL VO de 8/8h
  -



RESFRIADO



PRESCRIÇÃO AMBULATORIAL

Escolha o medicamento de acordo com os sintomas do paciente:

Febre e analgesia:
1) Dipirona 500 mg ---------- 1 cx
Tomar 1 comprimido, via oral, de 6/6h, se dor ou febre.

Coriza, espirro e congestão nasal – via oral:
1) Descon ---------- 1 fr
Tomar 10 mL, via oral, de 6/6h, se congestão nasal, coriza e/ou espirro.

Febre, analgesia, coriza, espirro e congestão nasal (combinação):
1) Cimegripe ---------- 1 cx
Tomar 1 comprimido, via oral, de 6/6h, se sintomas de resfriado.

Odinofagia:
1) Strepsils ---------- 1 cx
Dissolver 1 pastilha na boca, a cada 3-6h, se desconforto em garganta. (máx.: 5 pastilhas/dia)

Tosse seca:
1) Dropropizina 3mg/mL ---------- 1 fr
Tomar 10 mL, via oral, de 8/8h, se tosse seca.

Tosse produtiva:
1) Ambroxol 30 mg/5mL ---------- 1 fr
Tomar 5 mL, via oral, de 8/8h, se tosse produtiva.



Direitos Autorais

© 2024 Prescrevendo Educação Médica LTDA. Todos os direitos reservados.

Este material é protegido por leis de direitos autorais e sua reprodução, distribuição, exibição ou execução sem autorização prévia da Prescrevendo Educação Médica LTDA é estritamente proibida.

É permitido o uso deste conteúdo apenas para fins pessoais e educacionais. Qualquer uso comercial ou redistribuição, total ou parcial, sem consentimento por escrito, constitui violação das leis de propriedade intelectual.

Para solicitar permissões especiais ou obter mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail:

contato@prescrevendo.com

Siga nossa página no Instagram:

@_prescrevendo

